

2026 年度 診療報酬改定

管理者・指導医のための完全ガイド

賃上げ・DX・かかりつけ・急性期再編
— 4つの柱を読み解く

+3.09%

本体改定率

30 年ぶりの大幅引き上げ

本日の学習目標

分析できる

改定の構造的背景と4つの柱の相互関係を説明できる

評価できる

自院への影響を定量的に判断できる

創造できる

施設基準取得・維持の戦略ロードマップを立案できる

改定の歴史的 위치づけ

30 年ぶりの大幅プラス改定

2024 年

+0.88%

本体 +0.46%

2026 年

+3.09%

30 年ぶり

1994 年

+3.4%

過去最大

なぜ今、30 年ぶりの引き上げが必要になったのか？

改定率の内訳

賃上げ対応

+1.70%

約 7,700 億円（55%）

物価高騰対応

+0.76%

約 3,400 億円（25%）

食費・光熱水費

+0.09%

約 400 億円（3%）

経営難緊急

+0.44%

約 2,000 億円（14%）

改定の半分以上（55%）が「賃上げ」— これは政策的メッセージ

改定の 4 本柱

1

賃上げ・物価対応

ベースアップ評価料拡充
物価対応料新設

2

医療 DX 推進

旧加算廃止→
電子的診療情報連携に統合

3

かかりつけ医
機能強化

地域包括診療加算再編
生活習慣病管理料

4

急性期再編

地域包括医療病棟 6 区分化
救急体制加算化

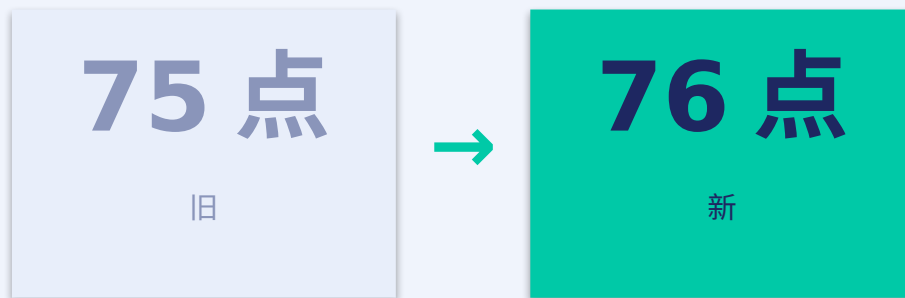
Section 1

外来改定のポイント

6つの主要変更を押さえる

- 再診料の引き上げ（75→76点）
- 機能強化加算 + BCP 義務化
- 地域包括診療加算の再編（2区分化）
- 生活習慣病管理料の変更（多科連携）
- ベースアップ評価料の拡充（6→17点）
- 物価対応料の新設

再診料・基本診療料



1 日 100 人の外来で年間約 36 万円増
初診料（288 点）・外来管理加算（52 点）は変更なし

機能強化加算と BCP 義務化

80 点（維持）

ただし施設基準に
BCP 策定が追加

2027 年 5 月 31 日

経過措置期限
未策定 = 算定不可

BCP = Business Continuity Plan（事業継続計画）
自然災害 + サイバーセキュリティの 2 本立て

地域包括診療加算の再編

認知症地域包括診療加算を統合 → 2 区分に再編

区分	点数	主な要件
加算 1	28 点	認知症対応力向上研修修了 + 従来要件
加算 2	20 点	従来の地域包括診療加算要件

管理職視点：研修修了者の確保が加算 1 の鍵
加算 1-2 の差額：8 点 / 回 → 年間約 28 万円差（100 人 / 日）

生活習慣病管理料

- 基本構造は維持（Ⅰ：610/740/780 点、Ⅱ：333 点）
- 新設：眼科連携加算・歯科連携加算
- 療養計画書の ICT 活用要件緩和

管理職視点：多職種・他科連携の体制整備が収益に直結

ベースアップ評価料

6 点

旧：医療従事者のみ



17 点

新：事務職員含む全職員

外来 100 人 / 日で年間約 600 万円増

注意：実際に賃上げに充てる必要あり（報告義務）

物価対応料（新設）

2026 年 6 月～

初診 2 点 / 再診 2 点

2027 年度～

初診 4 点 / 再診 4 点

倍増予定

小さく見えるが、積み上げると年間数十万円規模
2 段階実施：物価動向を見ながら段階的に対応

Section 2

入院改定のポイント

急性期再編の本丸

- 地域包括医療病棟の6区分化
- 急性期入院料の見直し
- 総合診療機能評価の新設
- 紹介患者受入加算の拡充（60点新設）
- 救急の体制加算化

地域包括医療病棟の 6 区分化

従来の一律評価 → 6 段階の機能分化

区分	要件概要
入院料 1（最高点）	救急搬送実績 + 自宅退院率高
入院料 2	救急搬送実績あり
入院料 3	一般的な包括医療
入院料 4-6	段階的な要件緩和

管理職視点：自院がどの区分に該当するか、早期に評価が必要

急性期入院料の再編

- 看護配置・重症度基準の精緻化
- 在宅復帰率の評価強化
- 「急性期」の定義が厳格化

対応できない病院は区分変更を検討すべきタイミング

総合診療機能評価

病院における総合診療の価値が初めて点数化

- 総合診療専門医の配置が評価対象に
- 複数診療科にまたがる患者の管理を評価

管理職視点：総合診療医の採用・育成が経営戦略として浮上
かかりつけ医機能報告制度との接点も注目

紹介患者受入加算

60 点

新設

- 逆紹介の推進（大病院→診療所の流れ）
- 紹介状なし受診の抑制策と連動

管理職視点：連携パスの整備が収益に直結

救急の体制加算化

旧：院内トリアージ実施料

実施ベースの評価



新：救急医療管理加算

体制ベースへの転換
時間帯別段階評価

管理職視点：救急受入体制の整備が安定収入源に

Section 3

医療 DX 改定

「体制整備」から「実績評価」へ
体制があるだけでは不十分、使われていることが必要

旧制度→新制度の統合

廃止

医療 DX 推進体制
整備加算

廃止

医療情報取得加算



統合

電子的診療情報
連携体制整備加算

3 区分（15 / 9 / 4 点）

電子的診療情報連携の 3 区分

区分 1

15 点

電子処方箋実績
+ マイナ利用率 30% 以上

区分 2

9 点

電子処方箋
体制あり

区分 3

4 点

マイナ基本体制
のみ

区分 1 vs 区分 3 = 11 点 / 回の差
1 日 100 人で年間約 400 万円の差

マイナ保険証利用率 30% の壁

30%

区分 1 取得の必須ライン

全国平均（2026 年 3 月時点）：約 15-20%

施設でできること

- 受付でのマイナ保険証利用促進
- ポスター掲示・声かけマニュアル
- カードリーダーの動線最適化

電子処方箋の要件

電子処方箋：もはや「対応済み」が前提

- 区分 1 ・ 2 の取得には電子処方箋が必須
- 導入コスト vs 長期的な加算収入

管理職視点：未導入なら最優先で導入計画を策定

Section 4

BCP 策定義務化

もう「あると良い」ではなく「なければ算定不可」

期限：2027年5月31日

機能強化加算・在支診・在支病の施設基準

自然災害 BCP チェックリスト

7つの策定項目

- 優先業務の特定と順位付け
- 職員参集計画（連絡網・代替手段）
- 患者安全確保手順
- ライフライン途絶時の対応
- 備蓄計画（医薬品・食料・燃料）
- 地域連携体制（受入・搬送）
- 年1回以上の訓練実施

サイバーセキュリティ BCP

- バックアップ体制（3-2-1 ルール）
- ランサムウェア対策（ネットワーク分離）
- 紙カルテ運用への切り替え手順
- 全職員向けセキュリティ教育（年1回以上）
- インシデント発生時の報告・対応フロー

2024 年だけで 33 件

医療機関へのサイバー攻撃

Section 5

経営戦略

自院への影響をどう評価するか

Step 1

現在の施設基準一覧を棚卸し

Step 2

改定後の点数変動をシミュレーション

Step 3

新規取得可能な施設基準を洗い出し

Step 4

投資対効果（ROI）で優先順位づけ

施設基準 優先度マトリクス

緊急度高 × 効果大

**BCP 策定（期限あり）
ベースアップ評価料申請**

緊急度低 × 効果大

**電子処方箋導入
地域包括診療加算 1**

緊急度高 × 効果小

物価対応料の届出

緊急度低 × 効果小

その他の加算見直し

全職員への伝え方

「改定は経営の話」で終わらせない

ベースアップ評価料

「あなたの給与に直結します」

マイナ保険証利用促進

「受付での声かけが収入を変えます」

BCP

「あなたと患者を守る計画です」

事務部門・看護部門・リハビリ部門それぞれの伝え方を変える

今日から始める 5 つのアクション

今週中

施設基準の棚卸し（現状把握）

今月中

BCP 策定プロジェクトチーム発足

来月中

マイナ保険証利用率の現状把握と目標設定

6 月

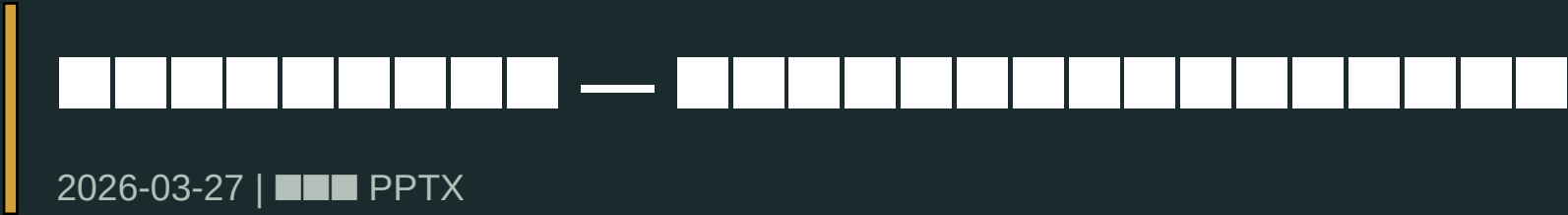
改定施行 — 算定開始

2027 年 5 月

BCP 経過措置期限 — 完了必須

自院で最もインパクトが大きい改定項目はどれか？

今日の帰りの車の中で考えてみてください。



2026-03-27 | ■■■ PPTX

あなたの研究計画書 そのまま通りますか？

- 文科省・厚労省・経産省の3省合同改正
- パプコメ：2025年12月～2026年1月（終了済み）
- 2026年度中に施行予定

指針が「複雑かつ難解」で研究を停滞させていた → シンプルに再設計

今日の学習目標（15 分）

説明できる

改正の 3 つの柱を述べられる

分析できる

自分の研究に影響する変更点を特定できる

書ける

新指針に準拠した研究計画書の骨子を書き始められる

Quick Poll

☒ 倫理指針を読んだことがある人？

☐ IC とオプトアウトの違いを説明できる人？

☒ 仮名加工情報を扱ったことがある人？

今日は「同意のとり方」と「個人情報の種類」の 2 軸で整理します。

改正の 3 つの柱

1

同意手続きの簡素化

IC とオプトアウトの二元化
場面ごとの分岐ルール → シンプルに

2

仮名加工情報の活用拡大

自機関で作成 → IC なし（オプトアウト）で OK
匿名加工情報の利用制限を撤廃

3

包括同意のルール明確化

包括同意だけでは不十分
+ オプトアウト手続きが必要に

あなたの研究、どの同意が必要？

研究で使うデータは？

新規に採取する試料
侵襲を伴う

→ IC 必須

既存の試料・情報

→ 下へ

匿名加工情報

同意不要（制限撤廃）

仮名加工情報（自機関作成）

オプトアウトで OK

包括同意取得済み

範囲内ならオプトアウト

その他の既存情報

オプトアウトが基本

ミニ研究計画書ワーク

ペアワーク 4分 — シナリオを1つ選んで骨子を書く

A: カルテ後方視

自施設の糖尿病患者 500 名のカルテデータを後方視的に解析したい

B: バイオバンク

包括同意取得済みの血液検体で新しいバイオマーカーを探索したい

C: AI 画像解析

匿名化済みの画像データで AI 診断ツールの精度を検証したい

決めるべきこと：

データの種類（個人情報 / 仮名加工 / 匿名加工） × 同意の方法（IC / オプトアウト / 不要）

各シナリオの正解

A: カルテ後方視

仮名加工情報に加工 → オプトアウトで OK

改正で： 現行では IC が必要なケースも → 簡素化

B: バイオバンク

包括同意の範囲内 → オプトアウト手続き

改正で： 包括同意だけでは不十分 → 組合せが明確化

C: AI 画像解析

匿名加工情報 → 同意不要

改正で： 「困難な場合」の制限が撤廃 → より自由に

3つの変更、3つのアクション

覚えておくこと

1. 同意手続きの二元化（IC + オプトアウト）
2. 仮名加工情報はオプトアウトで OK
3. 匿名加工情報の利用制限を撤廃

次のアクション

今すぐ

自分の研究の同意手続きが改正でどう変わるか確認

今週中

倫理審査委員会に新指針への移行スケジュールを問い合わせ

来月

新指針準拠の研究計画書ドラフトを書いている

改正は研究を「やりやすくする」方向。
ただし手続きは変わるので、今のうちに準備を。



2026-03-27 | ■■■ PPTX

新・家庭医療専門医制度の改訂

ポートフォリオ 2 割削減とかかりつけ医機能報告制度

これは「楽になった」のか？
それとも「質がもっと問われる」のか？

今日の学習目標（15 分）

- 説明できる — 制度変更の具体的内容と背景
- 比較できる — 旧制度と新制度の差分を分析
- 立案できる — ポートフォリオ戦略を描ける

20 → 16

ポートフォリオ領域
2 割削減

Quick Poll

☒ 新・家庭医療専門医制度のポートフォリオを書いたことがある人？

☒ 「かかりつけ医機能報告制度」という言葉を聞いたことがある人？

☒ 第 17 回 JPCA 学術大会（2026 年 5 月・京都）に参加予定の人？

専門医制度と医療政策が同時に動いています。
「制度を知る」ことは、キャリア戦略そのものです。

何が変わった？

旧制度

20 領域

学会発表 3 件以上



新制度

16 領域

学会発表 2 件以上

領域が「消えた」のではなく、既存領域に統合された。
→ 1 つのポートフォリオに求められる多面性と深さがむしろ増している。

統合された旧領域：

- 複雑困難事例 → 多疾患併存 (4) 等
- プロフェッショナルリズム → 医療者自身のケア (16)
- セクシャルヘルス・思春期 → 各関連領域
- 緩和ケア・最終段階 → 長期的関係 (5)

コア 16 領域は変更なし

- 1. 未分化な健康問題
- 2. 予防医学・健康増進
- 3. 慢性疾患 4. 多疾患併存
- 5. 長期的全人的関係 6. 患者中心
- 7. 家族志向 8. 地域志向 PC
- ...16. 医療者自身のケア

かかりつけ医機能報告制度

2025 年 4 月施行 | 初回報告 : 2026 年 1-3 月 (G-MIS)

報告制度で求められる能力

- 17 診療領域・40 疾患対応力
- 在宅医療・訪問診療の提供体制
- 総合診療専門医の配置 (報告項目)



家庭医療専門医の研修

- 16 ポートフォリオ領域
- 包括的なプライマリ・ケア能力
- 地域志向のアプローチ

あなたの存在が、医療機関の「かかりつけ医機能」を高める。
家庭医療専門医の研修で培う能力 ≡ 報告制度で求められる能力。

ペアディスカッション

3 分ペアワーク + 1 分シェア | 問いを 1 つ選んでください

問い A 専攻医向け

16 領域になった今、残りの研修期間で
どの領域を「質の高い事例」として書きたいか？

問い B 研修医向け

かかりつけ医機能報告制度で求められる能力のうち
今の研修で意識的に伸ばせるものは何か？

問い C 指導医向け

ポートフォリオ領域が統合された今、
指導でどんな点を強調するか？

振り返りと持ち帰り

1. 量から質へ

20→16 領域の削減は、1 事例あたりの深さ・多面性を重視する方向

2. 制度と教育の融合

かかりつけ医機能報告制度と専門医研修は同じ方向を向いている

3. あなたの価値

総合診療 / 家庭医療専門医は、これからの医療制度で求められる存在

次のアクション

今週

JPCA 公式サイトで新 16 領域の詳細を確認

来月

第 17 回 JPCA 学術大会（5/29-31 京都）の演題募集チェック

今月中

指導医とポートフォリオ進捗を振り返る

自分のポートフォリオで一番自信のある領域と、
一番苦手な領域は何か？ 苦手な領域をどの臨床場面で経験できるか？



2026-03-26 | ■■■■ PPTX

地域で支える緩和ケア

— 私たちにできること

20 分 | 全スタッフ向け

「この方、最近つらそうだな」
その「気づき」こそが、緩和ケアの出発点です。

「緩和ケア」と聞いて何を思い浮かべますか？

× 終末期の人だけが受けるもの

× がんの人だけが対象

× 特別な専門家だけがやること

× 「もう何もできない」

○ 診断されたときから始められる

○ 心不全、認知症、呼吸器疾患なども対象

○ すべての職種が関われる

○ 「できることはまだまだたくさんある」

「つらさ」には 4 つの種類がある

身体的

痛み、息苦しさ、だるさ、食欲不振

精神的

不安、うつ、恐れ、怒り

社会的

仕事・お金の心配、家族への負担

スピリチュアル

「自分の人生に意味はあったのか」

すべての職種が、どれかの「つらさ」に関われる。

数字で見る「実装のギャップ」

64.8%

の施設に緩和ケア相談体制あり

でも実際の利用は年数回程度

~10%

の施設が介護職に緩和教育を実施

最も接する時間が長い職種なのに

8-16h/ 日

介護職が利用者と過ごす時間

医師は数分～数十分

あなたの職種でできる緩和ケア

看護師

痛みや息苦しさの日常的な評価
「つらさの寒暖計」の活用

介護士

入浴・食事中の痛み観察
「いつもと違う」に気づく力

リハビリ

できることを増やすアプローチ
生活の質を支えるリハ

事務・相談員

制度利用の橋渡し
家族の相談窓口

グループワーク（5分）

隣の人と話し合ってください：

「あなたが最近関わった方で、
何かもう少しできたかもしれない、
と感じた場面はありますか？」

正解を求めません。感じたことを大切にしてください。

今日持って帰ってほしいこと

1

緩和ケアは終末期だけじゃない

診断時から、どの疾患でも、どの職種でも

2

あなたの「気づき」が出発点

8-16 時間一緒にいるあなただからこそ気づける

3

困ったら相談

緩和ケアチーム・地域連携室に声をかけてください

「自分には関係ない」→「自分にもできることがある」



AI × ■■■■ — ■■■■■■

2026-03-26 | ■■■ PPTX

使いこなす力と疑う力

80% 超

の医師が AI を臨床活用

しか
し…

AI+ 医師 < AI 単独

診断精度 76% vs 90%

AI は味方か、それとも新しい罠か？

— AMA 調査 / IME 2026 / Frontiers in Digital Health 2025

今日の学習目標（45 分）

説明できる

AI の 3 世代とマルチエージェントの概念

分析できる

AI が持つ認知バイアスの種類

判断できる

AI を使うべき場面と逆効果な場面

提案できる

自分の研修に AI をどう組み込むか

AI の進化 — 3 世代

第 1 世代 ルールベース

人間がルールを書く

例：処方チェックシステム

第 2 世代 生成 AI

1 つの AI が何でもやる

例：ChatGPT に症例を聞く

第 3 世代 エージェント AI

専門 AI チームが協力

例：複数 AI が分担して診断支援

マルチエージェント = チーム医療の AI 版

Supervisor Agent (総合医)

検査データ専門

画像診断専門

薬剤相互作用

ガイドライン照合

Mount Sinai 研究の 3 つの発見

精度向上 : マルチエージェントが単一 AI を統計的に有意に上回る

コスト削減 : 計算コストを最大 65 分の 1 に

スケーラビリティ : タスク増加でも性能維持 (単一 AI は低下)

AI が引き起こす認知バイアス

アンカリング

AI の最初の提案に引きずられる

対策

鑑別を自分で考えてから AI に聞く

自動化バイアス

AI が正しいと無条件に信じる

対策

「AI が言ったから」を理由にしない

確証バイアス

AI の答えを支持する情報だけ探す

対策

反証を意識的に探すルーチン

AI を使うべき場面 vs 使うと危ない場面

AI が得意

- 網羅的な鑑別診断リスト
- ガイドラインの確認
- 薬剤相互作用チェック
- 文献検索・要約
- 教育シナリオの生成

AI が危ない

- 未経験の症候の最終診断
- 患者の価値観を踏まえた意思決定
- 文脈依存の臨床判断
- ハルシネーション（もっともらしい嘘）
- 感情的サポートが必要な場面

AI は「考える相棒」であって「判断する主治医」ではない

AI ロールプレイ（15 分）

3 つの役割を体験してみましょう

Patient AI

症例を提示する
(症状・検査結果を段階的に開示)

Socratic AI

考えを深める質問をする
(「なぜそう考えた?」「他には?」)

Red Team AI

意図的に反論する
(「この診断を否定するエビデンスは?」)

3 人 1 組 | 各役割 5 分ずつ | 症例は配布シート参照

ロールプレイの振り返り

AI に引きずられた瞬間はあったか？

「自分で考える」と「AI に聞く」のバランスは？

Red Team の反論で気づきはあったか？

PNAS 2026: AI を使った群は、使わない群より確証バイアスが強くなった
→ 「疑う力」を意識的に鍛える必要がある

AI 活用の 3 つのルール

1

まず自分で考える

鑑別を 3 つ挙げてから AI に聞く
→ アンカリングを防ぐ

2

AI の答えを疑う

「AI が言ったから」を理由にしない
→ 反証を探すルーチン

3

使った過程を記録する

どの場面で AI を使い、どう判断したか
→ ポートフォリオに活かせる

持ち帰りのアクション

今日

次の症例で「まず自分で3つ鑑別」→ AIに聞く、を試す

今週

AIの提案を1回は意識的に疑ってみる

今月

AI活用の経験をポートフォリオに1つ書く

AIは最強の相棒になれる。でも、主治医はあなたです。



AI × ■■■■ — ■■■■■■

2026-03-26 | ■■■■ PPTX

AI × 医学教育

— 知っておきたい3つのこと

全スタッフ向け 20 分

80% 超の医師が AI を臨床で使い始めている

でも「使い方」を教わった人はほとんどいない

AI にできること・できないこと

得意なこと

- 大量の情報を素早く整理
- 文章の要約・翻訳
- パターンの認識（画像・数値）
- 24 時間 365 日、疲れない

苦手なこと

- 患者さんの気持ちを理解する
- 「いつもと違う」に気づく
- 責任を持って判断する
- 嘘をつくことがある（ハルシネーション）

AI は「道具」であって「判断者」ではない。
使う人の責任と判断が常に必要です。

AI 同士が協力する時代

チーム医療と同じ。1 人の天才より、専門家チームが強い。

リーダー AI（総合調整）

検査 AI

画像 AI

薬剤 AI

文献 AI

実際の成果（Mount Sinai 研究）：

- チーム AI が単独 AI より正確
- コストは最大 65 分の 1 に削減
- 患者が増えても質が落ちない

AI を使うときに気をつけること

⚠ もっともらしい嘘

AI は自信満々に間違えます。
必ず確認を。

⚠ 引きずられる危険

AI の最初の答えに引きずられがち。
自分の判断を先に持つ。

⚠ 個人情報の取り扱い

患者情報を AI に入力する際は
施設のルールを確認。

隣の人と話してみましょう

3 分間

あなたの業務で、AI が役立ちそうな場面は
どんなところですか？

逆に、「ここは AI に任せたくない」と思う場面は？

正解はありません。感じたことを共有してください。

3つだけ覚えてください

1

AI は道具

便利だけど「判断」はしない。
責任は常に人間にある。

2

AI 同士が協力する時代

チーム医療の AI 版。
1 つの AI より正確で安い。

3

使い方を学ぶのは今

80% の医師が使い始めた。
取り残されないために。



AI ■■■■ — Clinical Reasoning with AI

2026-03-25 | ■■■■ PPTX

AI は診断を助けるか？

臨床推論の認知バイアスと
AI 仮想患者の可能性と限界

研修医・専攻医向け勉強会 | 30 分 | 2026-03-25

Learning Design Lab

AI を使ったら、診断の正解率が下がった。

90%

GPT-4 単独

76%

医師 + GPT-4 補助

74%

医師 単独

— Frontiers in Digital Health, 2025

なぜ、AI を「使える」のに、
医師の精度はわずか 2% しか改善しなかったのか？

今日の学習目標

この 30 分の後、あなたは：

1 説明できる

臨床推論における 3 大認知バイアス
(アンカリング・プレマチュアクロージャール・利用可能性 H)

2 批判的に吟味できる

AI 仮想患者の「機能的忠実度」と
「会話的忠実度」の違い

3 判断できる

AI を使うべき場面と、
使うと逆効果になる場面

4 提案できる

自分の研修に AI をどう組み込むかの
アイデア

前提確認 — あなたの認知バイアス体験

Quick Poll (挙手)

☐ AI (ChatGPT など) を臨床で使ったことがある人?

☒ 使ったとき、AI の答えに引きずられた経験がある人?

☒ 逆に「AI は間違っている」と思って無視した経験がある人?

どちらも「認知バイアス」の一種です

臨床推論の 3 大認知バイアス

1. アンカリングバイアス

最初に得た情報に固執し、後の情報を過小評価する

例：「胸痛の 30 歳男性」→ 筋骨格系と決めつけ → 心筋炎を見逃す

2. プレマチュアクロージャー

十分な情報収集前に診断を確定してしまう

例：発熱 + 咳 → 「風邪でしょう」 → 肺炎を見逃す

3. 利用可能性ヒューリスティクス

最近経験した症例に引きずられる

例：先週コロナ 10 人 → 今日の発熱もコロナだろう

共通点：ワーキングメモリの制約（同時に 4-5 項目しか処理できない）が根本原因

AI はこれを「解決」できるか？

人間の限界	AI の特性
WM 4-5 項目	数千のデータを同時処理
最近の経験に引きずられる	訓練データ全体を均等に参照
疲労で精度低下	24 時間一定の精度
1 つの仮説に固執	複数仮説を並列評価

しかし現実には ...

AI を「答え合わせ」に使うと、自分の仮説を AI に確認させるだけになる

→ アンカリングバイアスを増強してしまう

AI の「正しい使い方」—— 3つの役割

1 Framework Coach (枠組みコーチ)
「この症例で見落としている鑑別は？」
と構造化を促す

2 Socratic Guide (ソクラテス的ガイド)
「なぜその診断だと思いますか？ 他の可能性は？」
と問いを立てる

3 Red Team Partner (レッドチーム)
「あなたの診断が間違っているとしたら、
最も危険な見逃しは？」と反論する

AI は「答えを出す道具」ではなく「問いを立てる鏡」として使うと効果的

ハンズオン体験（5分）

ペアワーク：AIに問診させてみよう

症例：45歳女性、2週間前からの倦怠感と微熱

1. Aさん：ChatGPT/Claudeに「患者役」をさせて問診（2分）
2. Bさん：AIに「ソクラテス的ガイド」として鑑別診断を検証（2分）
3. 体験を比較：どちらが「考えさせられた」か？（1分）

プロンプト例（患者役）

あなたは45歳女性の患者です。
2週間前からの倦怠感と微熱で
受診しました。医学生の間診練習に
協力してください。質問されるまで
情報を出さないでください。

プロンプト例（ソクラテス的ガイド）

私は研修医です。45歳女性、倦怠感
と微熱の患者を診ています。私の鑑別
診断に対して、見落としている可能性
をソクラテス的に問いかけてください。
答えは教えないでください。

AI 仮想患者のエビデンス — 何が分かっているか

	多施設横断研究 (JMIR 2026/3)	システマティックレビュー (JMIR 2026)
研究数	1（多施設）	39 本の統合
対象	英国 GP・医学生	国際的
機能的忠実度 （臨床精度）	高い ☒	高い ☒
会話的忠実度 （人間らしさ）	低い ⚠	低い ⚠
多疾患対応	未検証	苦手 ☒

2 つの独立した研究が同じ結論 → 現在の LLM 技術の構造的限界

機能的忠実度：臨床シナリオの正確さ（症状・検査値が医学的に正しいか）

会話的忠実度：人間の会話らしさ（自然な間、感情表現、非言語的要素）

なぜ「会話的忠実度」が低いのか？

Aziz (2026) の Systems & Complexity Lifecycle で理解する



Stage 1（安定）→ AI が得意

単一疾患の問診
ルールベースで再現可能
→ 機能的忠実度 高い

Stage 2 以降（創発）→ AI が苦手

多疾患 + 心理社会的文脈
創発的対話・関係性が必要
→ 会話的忠実度 低い

家庭医の日常は Stage 2 以降 → 最も必要なシミュレーションが AI の最も苦手な領域

臨床への実装 — 使い分けマトリクス

場面	AI の役割	推奨度
OSCE 事前練習（単一疾患）	模擬患者の代替	☑ 推奨
鑑別診断の網羅性チェック	レッドチームパートナー	☑ 推奨
EBM 文献の構造化要約	Framework Coach	☑ 推奨
複雑症例の臨床判断	答え合わせ	☒ 非推奨
多疾患患者のシミュレーション	模擬患者	⚠ 時期尚早
患者への共感的対応の練習	模擬患者	⚠ 不十分

Stage 1 の課題には AI を積極的に使う | Stage 2 以降の課題には人間の指導が不可欠

ディスカッション（5分）

3人グループで3分 → 全体共有2分

問い 1

「患者役 AI」と「ソクラテスのガイド AI」
のどちらが学びになりましたか？ なぜ？

問い 2

あなたの研修の中で、AIを「レッドチーム
パートナー」として使えそうな場面はどこですか？

問い 3

「機能的忠実度は高いが会話的忠実度は低い」
——患者さんへのAI活用でも同じことが言えそうですか？

持ち帰り

1 AI は答えを出す道具ではなく、問いを立てる鏡

受動的に使うとバイアスを増強する。能動的に使うと思考を拡張する。

2 「機能」と「会話」は別物

AI は臨床的に正確だが人間的ではない。Stage 1/2 の構造的違いで説明できる。

3 家庭医が扱う複雑さは、現在の AI の限界の先にある

だからこそ、限界を知った上で使いこなす力がこれからの医師に必要。

明日の外来で AI に 1 回聞いてみてください

「この患者の鑑別で私が見落としている可能性は？」と AI に聞いてみる。
来週、その体験をシェアしましょう。



■ ■ AI ■ ■ ■ — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2026-03-24 | ■ ■ ■ PPTX

医療 AI の実態 2026

光と影を踏まえて、使いこなすために

Doximity（米国医師向けプラットフォーム）8万人 + AMA（米国医師会）1,300人 調査から読む

研修医・専攻医向け 30分 | 2026-03-24

数字が語る現実

94%

医師が AI 利用中
または検討中

Doximity 2026

81%

AI 利用率
(2023 年 38% から倍
増)

AMA 2025

2 時間

1 日あたりの
時短効果

アンビエント AI

#1

家庭医が
AI 最頻度ユーザー

Doximity 2026

「AI は使えるのか？」のフェーズは終わった。問題は「どう安全に使うか」。

医師は何に AI を使っているのか

用途	割合	具体例
臨床ドキュメント作成	最多	Nuance DAX, Abridge, Suki
「パジャマタイム」解消	主目的	勤務外の事務作業を削減
診断支援	少ない	OpenEvidence 等
患者対応・ケア	非常に少ない	今後の拡大領域

「パジャマタイム」 = 勤務後にパジャマでカルテを書く時間。
AI が解消してくれるのは、「診断」ではなく「事務」。

光の側

OpenEvidence

日 100 万件

査読済み文献ベースの
臨床意思決定支援

AI 研修 RCT

保持率 91%

AI が研修医教育の
質を向上させる

Mount Sinai

コスト 65 分の

マルチエージェント AI が
1
単独より優秀

影の側

ECRI 患者安全

AI 診断が #1

ECRI = Emergency Care
Research
Institute (米国医療安全研究機構)
自動化バイアスが誤診リスクを増大

スタンフォード

半数が試験で評価

実患者データは
わずか 5%

AMA 倫理

監視の空洞

AMA = American Medical
Association
(米国医師会)
倫理ジャーナル廃刊 x AI センター設
立

国家レベルの応答

NAM = National Academy of Medicine (米国医学アカデミー)

「AI時代の患者安全」イニシアチブ -- 2026年3月発足

Mayo Clinic CEO らが共同議長

「To Err Is Human」(2000年の画期的報告書)の遺産を継承
AIを活用した「ゼロハーム」国家戦略を策定中

ECRI (米国医療安全研究機構) が「警告」を出し、NAM が「戦略」を立てる。
「光と影」のその先に、「制度設計」が始まっている。

安全に使うための 4 ステップ

フレームワーク「知る→疑う→補完→伝える」

(1) 知る

この AI は何で
評価された？

(2) 疑う

自分の判断と
照合する

(3) 補完

AI+ 人間の
強みを組み合わせ

(4) 伝える

患者に
透明性を保つ

[!] AI の答えを鵜呑みにしない。常に自分の臨床判断と照合する。

倫理の空洞 -- 誰が監視するのか

- AMA = American Medical Association（米国医師会）が倫理ジャーナルを廃刊
- 同時に AI センターを設立 -- 「倫理」より「実装」を優先する姿勢
- IC = Informed Consent（インフォームドコンセント：説明と同意）に AI 使用を含めるべきか未定
- VC = Venture Capital（ベンチャーキャピタル：投資ファンド）が医療 AI 市場に大量資金投入
- 「誰のための AI か」が問われている -- 患者か、効率化か、投資家か

テクノロジーの進歩に、倫理的議論が追いついていない。
だからこそ、現場の医師が考える必要がある。

ディスカッション

4 分間 → 全体共有 2 分

あなたが AI を使って「助かった」経験と
「危なかった」経験は？
その違いは何だったか？

考えるヒント

- AI の答えをそのまま使ったことはあるか？
- 患者に AI 使用を伝えたことはあるか？
- AI の間違いに気づいた経験はあるか？

持ち帰り

来週までの 1 アクション

- 自分が使っている（または使おうとしている）AIの「評価方法」を調べる
- 同僚と「AIの答えが自分の判断と違った経験」を共有
- 「パジャマタイム」がどれくらいあるか、自分で計測してみる

医師の 94% が使っているのに、
「どう安全に使うか」を議論している人はほとんどいない。

それを議論できるあなたは、もう一歩先にいる。



■ ■ AI ■ ■ ■ — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2026-03-24 | ■ ■ ■ ■ PPTX

医療 AI の「今」を知る

私たちの働き方はどう変わるのか

全スタッフ向け 15 分 | 2026-03-24

AI は今、医療でどう使われているか

94%

の医師が
AI を利用中・検討中

Doximity
(米国医師向けプラットフォーム)

81%

の AI 利用率
(2 年前は 38%)

AMA
(米国医師会)

2 時間 +

の時間短縮
1 日あたり

音声 AI
カルテ記録

AI は「特別なもの」から「日常のツール」になりつつある

AI が担っていること・まだ担えないこと

領域	AI の役割	私たちへの影響
カルテ記録	医師の音声を自動で文書化	記録業務の負担減
事務作業	書類作成・要約を支援	残業時間の短縮
診断支援	情報提示（最終判断は医師）	判断の参考として活用
患者対応	まだ発展途上	人間にしかできない領域

[!] AI は「医師の代わり」ではなく「医療チームの支援ツール」

AI の光と影

【+】 光の側

- カルテ記録時間が大幅に短縮
- 医師の燃え尽き症候群の軽減
- 研修医教育の質が向上（保持率 91%）
- 膨大な文献を瞬時に検索・要約

【!】 影の側

- AI の誤りを見逃すリスク
- 実際の患者データでの検証が不十分
- 個人情報保護の課題
- 「AI に任せきり」の危険性

大切なのは「光」だけでも「影」だけでもなく、両方を知ること

私たちにできること

知る

AI が何をしているか
理解する

確認する

AI の結果を
鵜呑みにしない

伝える

患者さんに
正直に説明する

学び続ける

新しい技術に
関心を持ち続ける

AI は「使う側」の姿勢で結果が変わる

よくある質問

質問	回答
AI に仕事を奪われる？	現時点では「代替」ではなく「支援」。事務作業の負担軽減が中心
患者の情報は大丈夫？	個人情報保護は最重要課題。施設のルールに従うことが大切
私も使うべき？	まずは「何ができるか」を知ることから。無理に使う必要はない
間違えたら誰の責任？	最終判断は医療者。AI は参考情報の提供者

今日の持ち帰り

- 医療 AI は急速に広がっている -- 医師の 94% が利用中・検討中
- 主な用途は「カルテ記録」と「事務作業」の効率化
- 光（時短・質の向上）と影（誤りのリスク・倫理課題）の両面がある
- 大切なのは「知る・確認する・伝える・学び続ける」の 4 つ

AI は「怖いもの」でも「魔法」でもない。
正しく知って、賢く付き合っていくための第一歩。


$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2026-03-24 | ■■■■ PPTX

Orchestrator

オーケストレーターとしての家庭医

AI 研究が証明した「統合者」の価値

Google/MIT マルチエージェント研究 x 家庭医療のエビデンス

2026-03-24

AI が証明したこと

Google / MIT / DeepMind 共同研究 (2025-2026)
単一 AI のエラー率を「1」としたとき、専門 AI を増やすと...

統合者なし (Bag of Agents)

エラー 17 倍に増
幅

専門家が個別に動くと
矛盾・重複・欠落が雪だるま式

統合者あり (Orchestrated)

エラー 4 倍に抑制

統合者が全体を調整すると
エラーの増幅を約 75% 抑制

「専門家の数」より「調整の構造」が重要。
これは、まさに医療の話だ。

AI の発見 = 医療の現実

AI マルチエージェント	日本の医療
専門 AI がバラバラに動く (「Bag of Agents」)	専門医がバラバラに診る (ポリドクタリング)
オーケストレーター AI が 全体を統合	家庭医がオーケストレーター として統合
エラー 17 倍 → 4 倍に抑制	ポリファーマシー 2.18 倍 → 抑制
コスト 80% 削減	外来費用約 2 倍 → 抑制

1975 年、日野原重明が「プライマリケアのニードはきわめて高い」と意見具申。
2004 年、岩崎榄が「分化ばかり進んで統合がなおざり」と指摘。
2009 年、Hutt が「患者のオーケストラの指揮者がいない」と論考。
→ 50 年間の警告が、2026 年の AI 研究で科学的に裏付けられた。

日本の現実 — 数字が語る断片化

0.3%

全医師に対する
家庭医の割合

1,126 人 / 339,623 人
(2022 年)

65.3%

高齢者の
ポリドクタリング率

複数施設を定期受診
(平均併存疾患 4.7)

2.18 倍

ポリファーマシー
のリスク

3 施設以上受診時
(OR 2.18)

2 倍

外来医療費の
増加

3 施設以上受診時
vs 1 施設

出典 : PMC (2023), BMC Health Services Research (2020), Scientific Reports (2025)

スターフィールドのエビデンス

Barbara Starfield (Johns Hopkins, 2005) — プライマリケアの定量的証明

プライマリケア医
1人/万人 ↑

死亡率 5.3%↓

年間 49 人 /10 万人の
命が救われる

プライマリケア
スコア 5 点 ↑

心疾患早死
最大 15%↓

営気管炎による
早死も 6.5%↓

米国での試算

年間 12.8 万人
の死亡を予防可能

プライマリケアを
充実させることで

出典 : Milbank Quarterly (2005), Macinko et al. (2007) — PMC2690145

世界の「オーケストレーター」モデル

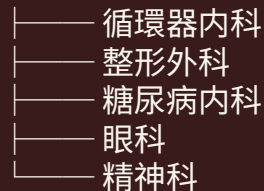
国	家庭医の役割	仕組み	成果
英国	ゲートキーパー + QOF(質評価)	NHS における GP システム	不利な地域の受診率向上
オランダ	ゲートキーパー (専門医には紹介必須)	包括払い制度 糖尿病・ COPD 管理	糖尿病の質指標改善
デンマーク	ゲートキーパー + グループ診療	OECD 最高評価の PC	予防可能な入院率低下
オーストラリア	GP がゲートキーパー + チームベース	Medicare のかかりつけ医 (GP) 登録制	慢性疾患管理の 国際的成功例
米国	FM/IM が PCP として機能 保険種で GK の有無が変わる	HMO: 紹介必要 PPO: 自由受診可能	PCP 不足が深刻 PC 弱い地域で死亡率 ↑
日本	フリーアクセス	患者が自由に	ポリドクターリング 65%

ゲートキーパー = AI の「オーケストレーター検証ゲート」。
家庭医を通さないと専門医に行けない仕組みが、
構造的に不要な受診を抑制し、ケアの質を上げる。

なぜ「統合者」が必要なのか

断片化したケア

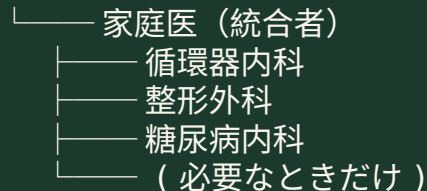
患者



→ 誰が全体を見る？

統合されたケア

患者



→ 全体を見る人がいる

AI も医療も同じ結論：「専門家の数」ではなく「調整の構造」が質を決める

スターフィールドの 4 つの柱

強いプライマリケア = この 4 つが揃っている

First Contact 最初の窓口

患者が最初に相談する
場所がある

Continuity 継続性

同じ医師が長期的に
一人の患者を診る

Comprehensiveness 包括性

幅広い問題に
対応できる

Coordination 調整機能

専門医との連携を
統合する

AI のオーケストレーター = 「Coordination」の役割。家庭医 = 4 つ全てを担う「システムの専門医」

ディスカッション

4 分間 → 全体共有 3 分

あなたの現場で、「オーケストレーターがいないせいで起きている問題」は何か？
それを解決するには何が必要？

考えるヒント

- ポリドクタリングで困った患者さんの経験は？
- 「全体を見る人」がいたら何が変わる？
- 日本のフリーアクセス制度をどう思う？

家庭医は「システムの専門医」である

専門医	家庭医
臓器の専門家	「人」の専門家
深く狭く	広くつなぐ
各パーツを最適化	システム全体を最適化
AI の専門エージェント	AI のオーケストレーター

Google/MIT が証明したこと：
「専門家の数」より「統合の質」が成果を決める。

家庭医は、「何でも診る医師」ではない。
「全体を見て、つないで、守る」システムの専門家だ。



CBE/EPA ■■ — ■■■■■■■■■■■■■■■■

2026-03-24 | ■■■ PPTX

CBE / EPA

Competency-Based Education / Entrustable Professional Activity

コンピテンシー基盤型教育と EPA -- 「点数」から「できること」へ

指導医・プログラムディレクター向け | 30 分 | 2026-03-24

導入の問い

USMLE（米国医師国家試験）で高得点の研修医が、
必ずしも「良い医師」になるとは限らない。
-- では、何で評価すればいいのか？

この 30 分の後、あなたは：

- CBE = Competency-Based Education（コンピテンシー基盤型教育）の基本概念を説明できる
- EPA = Entrustable Professional Activity（任せられる専門的活動）とマイルストーン評価を理解できる
- 自分の指導・研修に CBE の要素を 1 つ取り入れる計画を立てられる

試験の点数は何を予測するのか？

指標	事実	意味
USMLE Step 1 高得点	レジデントの臨床 パフォーマンスを予測しない	知識 ≠ 能力
クラークシップ 「優秀」評価	施設間で 5% ～ 67% のばらつき	基準が曖昧
筆記試験	「知っている」を測るが 「できる」を測らない	評価方法の不整合

「試験に受かる力」と「患者を診る力」は別物。
このギャップを埋めるのが CBE。

CBE（コンピテンシー基盤型教育）とは何か

	従来の教育	CBE
評価基準	時間（何年間研修したか）	能力（何ができるようになったか）
測定方法	筆記試験・口頭試験	EPA（実際の信頼レベル） + マイルストーン
指導者の役割	試験官・評価者	コーチ・伴走者
ゴール	合格ラインを越える	一人前の医師として任せられる

CBE = 「何年研修したか」ではなく「何ができるようになったか」で評価する仕組み

EPA -- 「任せられる」を段階的に評価する

EPA = Entrustable Professional Activity (任せられる専門的活動)

Level 1	観察のみ	見学している段階
----------------	-------------	----------

Level 2	直接指導下	指導医が横で見ている
----------------	--------------	------------

Level 3	間接指導下	一人でやって後で確認
----------------	--------------	------------

Level 4	自立実施	任せられる!
----------------	-------------	--------

Level 5	他者を指導	教える側になる
----------------	--------------	---------

「この研修医にこの行動を任せられるか？」が評価の核心

「評価者」から「コーチ」へ

	従来の指導医	CBE のコーチ
スタンス	「できなかったこと」を指摘	「できるようになったこと」を確認
フィードバック	年に 1-2 回の総括評価	日常的な短い対話
目的	合否判定	成長支援
関係性	上下関係	伴走・協働

「あの先生は厳しい」と言われる指導医から、
「あの先生がいると安心」と言われるコーチへ。

日本での動き

- 総合診療専門医制度（2017 年～）で EPA 的評価が導入され始めている
- 初期研修の「行動目標」が実質的な EPA に相当
- USMLE Step 1 の「Pass/Fail」化（2022 年）が全米で「点数から能力へ」の潮流を加速
- 日本の OSCE（客観的臨床能力試験）も「できる」を測る方向へ進化中
- 3/22 の AI 教育 RCT（保持率 91%）が示すように、AI が CBE を支援する時代が来ている

「点数で評価」から「任せられるかで評価」への転換は、日本でも始まっている

ディスカッション

4 分間 → 全体共有 2 分

あなたの研修現場で、
「点数では測れないが、医師として重要な能力」は何か？
それをどう評価すればいい？

明日からの 1 アクション

- 研修医の「できること」を 1 つ、EPA の Level で評価してみる
- 「できなかったこと」ではなく「できたこと」をフィードバックする
- 「次はこれを任せてみようか」という対話を、1 回してみる



2026-03-21 | ■■■ PPTX

デジタル時代のナラティブ・メディスン

物語の力 x 臨床思考 x デジタルツールの統合

研修医・専攻医向け | 30 分 | 2026-03-21

導入の問い

最近診た患者さんの中で、病歴だけでは
捉えきれなかった「何か」を感じた経験はありますか？

この 30 分の後、あなたは：

- ナラティブ・メディスンの理論的背景を説明できる（理解）
- デジタル・ナラティブの可能性と限界を論じられる（分析）
- 臨床思考との統合アプローチを 1 つ導入する計画を立てられる（創造）

ナラティブ・メディスンとは

Rita Charon のフレームワーク（Columbia, 2001）

要素	意味	臨床での実践
Attention	注意深く聴く	患者の語りに意識を向ける
Representation	物語を表現する	聴いたことを言語化・記録する
Affiliation	繋がりを形成する	患者との治療的関係を深める

ナラティブ・メディスン = 患者の物語を医療の中核に据えるアプローチ。
「聴く→表現する→繋がる」の3つのステップで、医師 - 患者関係を深める。

ナラティブ教育の現実 — 4つの構造的障壁

Frontiers in Medicine, 2026

☒ カリキュラム過密

ナラティブ教育の時間確保が困難

☒ 教員の準備不足

ナラティブを教えるトレーニングが未体系化

☒ 評価方法の不整合

ナラティブ能力をどう測定するか未解決

☒ 長期アウトカム研究の不足

ケアの質・燃え尽き防止への効果が未検証

構造的な障壁を無視すると形骸化する — システム思考で「レバレッジポイント」を見極めよう

デジタル・ナラティブ・メディシンの登場

JMIR, 2026 — デジタルがナラティブを拡張する 3 つの方向

患者 エンパワーメント

共同設計（co-design）
患者参加型ケア
アドボカシー

ケアチームの 人間化

物語のデジタル可視化
カルテを超えた記録
人間化の架け橋

教育への応用

AI 構造化分析
共感教育の支援
臨床推論との統合

限界： デジタルデバイド | プライバシー | 構造化が物語の豊かさを損なうリスク

ナラティブ x 臨床思考の統合

BMC Medical Education, 2025 — 神経内科での実証

項目	内容
方法	ナラティブ + 臨床思考 vs 従来教育
結果	統合群が有意に高い学習成果
意味	ナラティブと臨床思考は相補的

統合モデル概念図

患者の物語
↓ Attention
物語の構造化
↓ 臨床思考モデル適用
仮説生成 ↔ パターン認識
↓ Affiliation
統合的臨床判断

批判的吟味

- Study Design: 単施設、サンプルサイズは？
- 「高い学習成果」の測定方法は適切か？
- 一般化可能性と教育者効果の交絡は？

ペアディスカッション

4 分間 → 全体共有 2 分

あなたの臨床現場で、ナラティブ x 臨床思考 x デジタルツールの統合を 1 つ実践するとしたら、何ができるか？

考えるヒント

- 外来の問診にナラティブの要素を 1 つ追加するなら？
- カンファレンスで「患者の物語」を構造的に共有する方法は？
- デジタルツール（音声記録、テンプレート等）をどう使えるか？

3つの論文が示す全体像

論文	視点	あなたの臨床に
Frontiers	理想と障壁	現場の制約を知って設計
JMIR	デジタルの可能性	障壁を突破するツール
BMC	統合の実証	物語 + 構造が効くエビデンス

来週までの1アクション（1つ選ぼう）

- 患者の語りに3分間、中断せず耳を傾けてみる
- カルテ「現病歴」に患者の言葉を1文そのまま記載
- 同僚と「心に残った患者の物語」を1つ共有

持ち帰りの問い：デジタルツールが「記録」を便利にする一方で、
聴く力そのものはテクノロジーでは代替できない。
デジタル時代に「聴く力」をどう育むか？



2026-03-21 | ■■■■ PPTX

患者さんの「物語」をケアに活かす

デジタル時代のナラティブ・ケア入門

全スタッフ向け | 15 分 | 2026-03-21

ある日の退院時に

「先生の治療も嬉しかったけど、
あの看護師さんが毎朝
"今日はどんな夢を見ましたか？"
って聞いてくれたのが
一番の薬だったよ。」

今日のゴール

- 「ナラティブ・ケア」の考え方がわかる
- 自分の業務で患者さんの物語を活かす方法を 1 つ挙げられる

ナラティブ・ケアって何？

ナラティブ = 物語。患者さんの物語に耳を傾け、ケアに活かすこと。

病歴（データ）	物語（ナラティブ）
2 型糖尿病，HbA1c 8.2%	「妻が作る煮物が甘くて…でもそれが楽しみ」
左大腿骨頸部骨折	「孫の運動会を見に行きたかった…」
不眠症	「夫を亡くしてから、隣が空いてるのが怖い」

左が「何の病気か」。右が「どんな人生か」。
両方わかると、もっと良いケアができる。

物語を聴くと、何が変わる？

最新の研究でわかったこと

☒ 患者さんのストレスが軽減

物語を聴いてもらえた患者は不安や孤立感が減る

☒ 医療者の判断の質が向上

患者の背景を知ると、より適切な治療選択ができる

☒ チームケアが深まる

物語の共有で多職種連携が改善する

ただの「優しさ」ではなく、ケアの質を上げるスキル

あなたの職種だからこそ 聴ける物語がある

職種	いつ聴ける？	どんな物語？
☒ 看護師	バイタル測定中、ケア中	日常の不安、希望、家族のこと
☒ 介護士	入浴介助、食事介助中	生活歴、こだわり、好きなもの
☒ 事務職員	受付、会計時	通院の困りごと、第一印象
☒ 薬剤師	服薬指導中	薬への不安、生活リズム

どの職種も、患者さんにとって大切な「聴いてくれる人」になれます

みんなで考えよう

グループワーク | 3 分間

最近、患者さんから聴いた
「心に残った一言」はありますか？
それをチームにどう共有したら、
ケアが良くなると思いますか？

話すヒント

- 大きなエピソードじゃなくて OK
- 「もっと聴きたかったけど時間がなかった」でも OK
- 守秘義務の範囲で（個人が特定されない形で）

明日からできる「1日1聴」チャレンジ

職種	1日1聴アクション
看護師	バイタル測定するとき「今日の気分はどうですか?」と聴く
介護士	食事介助のとき「好きな食べ物の思い出」を1つ聴く
事務	受付で「今日はどうやって来られましたか?」と声をかける
全員	聴いた一言を、申し送りノートに1行だけ書く

「聴く」ことは、特別なスキルではなく、
あなたがすでに毎日やっていることの延長線上にあります。

☒ 参考文献リスト（別紙配布）



Multi Agent Ai Slides Allstaff

education/archive/2026-03-21_multi-agent-ai-healthcare/multi-agent-ai_slides_allstaff.pdf

AI が病院で どう使われ始めているか

最新研究から見える未来

全スタッフ向け | 15 分 | 2026-03-21

AI って結局なに？

まずはここから！

- ☒ 「ChatGPT に質問したことがある人？」 → きっと多い
 - ☒ 「AI に仕事を任せたことがある人？」 → きっと少ない
- ここが今日のテーマ！

今日のゴール

- 「AI エージェント」がどういうものかイメージできる
- 医療 AI が自分の業務にどう関わるか考えられる

「質問に答える AI」から 「仕事をする AI」へ

	今までの AI	これからの AI
例え	辞書・百科事典	新人スタッフ
できること	聞いたことに答える	指示を受けて自分で動く
イメージ	「〇〇って何? 」→回答	「業務お願い」→自分で判断

身近な例

- 「検査結果をチェックして異常値があったら教えて」
- 「退院サマリーの下書きを作って」
- 「患者データを集計してグラフにして」

チームで働く AI

Mount Sinai 病院の研究：

「AI も、1 人より「チーム」の方が良い仕事をする」

チーム医療	チーム AI
医師が方針を決める	リーダー AI が全体を管理
看護師が観察・ケア	データ確認 AI が異常を検知
薬剤師が薬をチェック	薬剤チェック AI が確認
事務が書類を整理	書類 AI が記録を整理

正確

チーム AI > 1 人の AI

65 分の
1

コスト削減

品質維持

仕事が増えても

まさに、チーム医療の AI 版！

AI は味方です

⚠ よくある心配とお答え

「仕事を奪われるのでは？」

→ 電子カルテ導入で人が不要になりましたか？ むしろ人間にしかできない業務に集中できるようになった。AI も同じです。

「信頼できるの？」

→ だからこそ「チーム」が大事。1つのAIが間違えても、他がチェックする。

AI が得意なこと → 定型作業、データ処理、パターン検出
人間が得意なこと → 共感、判断、患者さんとの対話

みんなで考えよう

グループワーク | 3 分間

あなたの業務の中で、
「これ、AI に手伝ってもらえたら助かるなあ」
と思うことはありますか？

考えるヒント

- 毎日繰り返している定型作業は？
- 「もう 1 人いたらなあ」と思う場面は？
- データの入力や転記で時間を取られることは？

これからどうなる？

時期	予想される変化
今～1年後	書類作成・データ集計の補助が普及
1～3年後	検査結果の自動チェック・アラートが標準化
3～5年後	チーム AI が日常的に業務を支援

テクノロジーは変わっても、
患者さんの手を握れるのは、あなただけです。

AI が得意なことは AI に。
人間にしかできないことに、もっと時間を使えるように。



Multi Agent Ai Slides Residents

education/archive/2026-03-21_multi-agent-ai-healthcare/multi-agent-ai_slides_residents.pdf

AI が病院でどう働くか

マルチエージェント AI の医療実証研究 — Mount Sinai 論文を読む

研修医・専攻医向け | 30 分 | 2026-03-21

導入の問い

もし優秀な医師が 1 人いるのと、
それぞれの専門が違う普通の医師が 5 人いるチームと、
どちらに難しい症例を任せたいですか？

この 30 分の後、あなたは：

- マルチエージェント AI の基本概念を説明できる（理解）
- Mount Sinai 研究の Study Design を批判的に吟味できる（分析）
- 自分の臨床現場での AI 活用可能性を 1 つ提案できる（創造）

医療 AI の進化 — 3 つの世代

世代	特徴	医療での例
第 1 世代：ルールベース	人間がルールを書く	処方チェックシステム
第 2 世代：生成 AI	1 つの AI が何でもやる	ChatGPT に症例を聞く
第 3 世代：エージェント AI	専門 AI チームが協力	複数 AI が分担して診断支援

マルチエージェント = チーム医療の AI 版

[Supervisor Agent] (総合医)
├── [Agent A] 検査データ専門
├── [Agent B] 画像診断専門
├── [Agent C] 薬剤相互作用専門
└── [Agent D] ガイドライン照合専門

チーム医療と同じ構造
1 人の総合医がすべてやるより
専門家チームの方が強い

Mount Sinai 研究の結果

npj Health Systems, 2026

精度

**有意に
上回る**

特に複雑な
医療タスクで顕著

コスト

65 分の 1

計算コストを
大幅削減

スケール

**性能
維持**

タスク増加でも
品質低下なし

救急外来で 10 人同時搬送：スーパードクター 1 人 → 限界 / 専門チーム 5 人 → 並列処理 + 専門性

批判的吟味

観点	強み	限界・疑問
新規性	医療でのマルチエージェント実証は少ない	実臨床にどれだけ近いタスクか？
定量性	65 倍のコスト削減は具体的	ベンチマーク選定は適切か？
再現性	Mount Sinai の信頼性	他施設での再現は？
臨床的意義	チーム医療と同構造	患者アウトカムは直接示されているか？
安全性	—	判断ミスの検出機構は？

考えるべき問い

- 65 倍のコスト削減 — 比較対象は公平か？
- 統計的有意 ≠ 臨床的有意
- エージェント誤判断時の安全装置は？
- 日本の医療にそのまま適用できるか？

ペアディスカッション

4 分間 → 全体共有 2 分

あなたの臨床現場（外来・病棟・救急）で、
マルチエージェント AI が活躍できそうな場面を
1 つ考えてください。
どんな「専門エージェント」が必要ですか？

考えるヒント

- 複数の情報源を同時に確認する場面は？
- 「誰かに自動チェックしてほしい」業務は？
- カンファレンスの事前準備を効率化するなら？

業界トレンド

1,445%

問い合わせ急増
(Gartner)

3 倍

タスク完了速度

60%↑

精度向上

human-in-the-loop	human-on-the-loop
AI が提案→人間が毎回承認	AI が自律実行→人間が監督
安全だが遅い	速いが信頼性設計が重要

「人間がチェックしなくてもいい AI」は、医療でどこまで許されるか？

持ち帰りの問い

来週の 1 アクション

- 自分の業務で「複数情報を同時確認する場面」を 1 つメモ
- 同僚と「AI に任せたい業務」について 1 回話す
- Mount Sinai 論文の Abstract を読んでみる

チーム医療では「誰が最終責任を負うか」が明確です。
マルチエージェント AI では、誰が責任を負うのでしょうか？

— この問いは、AI の技術問題ではなく、医療倫理の問題です。



Ai Agent Team Overview Slides

meta/2026-03-28_ai-agent-team-overview/ai-agent-team-overview_slides.pdf

AI Agent Team

学びをデザインする 9 人のエージェント会社

9

Agents

Learning Design Lab | CEO: たまさん（家庭医 × 教育者 × AI 実践者）

なぜ AI エージェントチーム？

課題

情報過多：医療 × AI × 教育、毎日膨大な情報が流れる

時間不足：臨床・教育・研究の合間に処理しきれない

発信したい：学びを届けたいが制作時間が足りない

解決策

9 人の AI エージェントが 24 時間稼働

情報収集→分析→教材→コンテンツを自動化

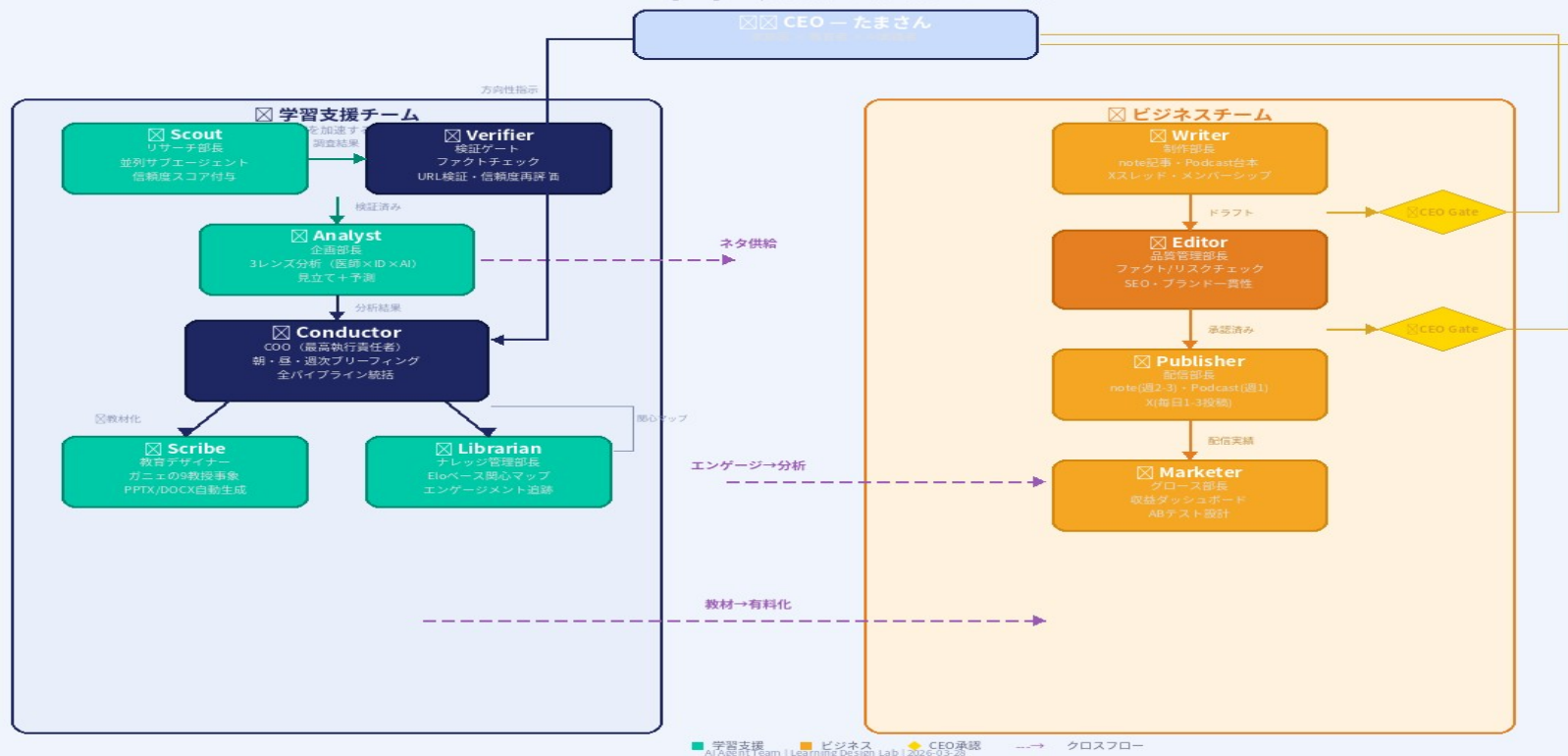
たまさんは「判断」と「声」に集中

一人会社だけど、チームで動く — それが AI エージェントカンパニー

チーム相関図

AI Agent Team — チーム相関図

Learning Design Lab | 学びをデザインする9人のエージェント会社



☒ 学習支援チーム

たまさんの学びを加速する 6 エージェント

Scout

リサーチ部長

Verifier

検証ゲート

Analyst

企画部長

Conductor

COO

Scribe

教育デザイナー

Librarian

ナレッジ管理

Scout → Verifier → Analyst → CEO 判断 → Scribe → Librarian

Scout & Verifier — 情報収集と検証

Scout — リサーチ部長

- 並列サブエージェントで 4 クラスター同時調査
- 一次ソース（論文・公式）と二次ソース（まとめ）を区別
- 信頼度スコア（high/medium/low）付与
- トリガー：/scout [トピック]

Verifier — 検証ゲート

- Scout 出力のファクトチェック
- URL 検証・ソース到達確認
- 信頼度の再評価
- パイプライン上の品質フィルター

Analyst & Scribe — 分析と教材化

Analyst — 企画部長

- 3つのレンズで深掘り（医師 ×ID×AI）
- Conductor の見立て+予測
- 独自の切り口を発見
- トリガー：/analyst [トピック]

Scribe — 教育デザイナー

- ガニエの9教授事象に基づく設計
- 対象者別出力（研修医・全職員）
- PPTX + DOCX 自動生成
- トリガー：/scribe [トピック]

Conductor & Librarian — 統括とナレッジ

Conductor — COO（最高執行責任者）

- 朝・昼・週次の3モードブリーフィング
- 全パイプラインのオーケストレーション
- 承認ゲート管理
- トリガー：/briefing

Librarian — ナレッジ管理部長

- Elo ベースの関心マップ（50 トピック）
- ♥ エンゲージメント追跡
- 週次レトロスペクティブ
- トリガー：/librarian

☒ ビジネスチーム

学びを届ける 4 エージェント

Writer

制作部長

Editor

品質管理部長

Publisher

配信部長

Marketer

グロース部長

Scout → Analyst → CEO → Writer → Editor → CEO → Publisher → Marketer

コンテンツの 4 本柱

学び方のデザイン

AI エージェント一人会社

家庭医の視点

趣味で学ぶ ID

Writer & Editor — 制作と品質保証

Writer — 制作部長

フォーマット	内容
note 無料	学び方のデザイン・AI 活用
note 有料	深掘り分析・実践ガイド
Podcast 台本	対話形式・20-30 分
X スレッド	要点まとめ・速報
メンバーシップ	限定コンテンツ・Q&A

トリガー : /writer [テーマ]

Editor — 品質管理部長

- 文章品質
- ファクトチェック
- リスクチェック（医師法・薬機法）
- SEO・発見性
- ブランド一貫性

トリガー : /editor [ファイル]

CEO ゲート : Writer→Editor の出力はたまさんの最終承認が必要

Publisher & Marketer — 配信と成長

Publisher — 配信部長

note.com — 週 2-3 本

Podcast — 週 1 回・20-30 分

X — 毎日 1-3 投稿

教育モード : Scribe 出力→ PPTX/DOCX

トリガー : /publisher [ファイル]

Marketer — グロース部長

- フォロワー / リスナー数トラッキング
- 収益ダッシュボード
- 成長戦略立案
- AB テスト設計

トリガー : /marketer

パイプライン全体像 — 学習からビジネスへ

学習パイプライン



↓ クロスフロー：調査結果→ネタ元 / 教材→有料コンテンツ ↓

ビジネスパイプライン



学習チームの調査結果がビジネスチームのネタ元に。Scribe の教材が有料コンテンツに。

進化ロードマップ

Phase 1 (Now)

基盤強化

- cron 安定化・認証セッション維持
- モバイル連携（Claude Code Channels）
- ダッシュボード改善

Phase 2 (Next)

自律化

- 秘書 Agent（進捗横断管理）
- A2A プロトコル（エージェント間通信標準化）
- n8n ワークフロー（可視化・エラー通知）

Phase 3 (Future)

マルチ LLM 拡張

- Gemini 連携（長文コンテキスト活用）
- NotebookLM（ポッドキャスト自動生成）
- 外部 API 統合

注目アイデア 4 選

1 秘書 Agent

「誰がどこまで進んだか」を横断管理。Conductor の負荷分散

2 A2A プロトコル

Agent Card によるサービスディスカバリ。動的ルーティング

3 n8n ワークフロー

パイプラインの可視化。エラー通知・リトライ一元管理

4 Gemini × NotebookLM

マルチ LLM 活用。ポッドキャスト音声自動生成の可能性

Vision — たまさんが判断に集中できる世界

情報収集・分析・制作・配信…すべてをエージェントが担い、
たまさんは「何を学ぶか」「何を届けるか」の判断だけに集中する

現在

週 5-8 時間の関与（方向性決定・最終承認・声入れ）

目標

判断以外の作業時間をゼロに近づける

最終形

学びと発信が自然に回り続けるエコシステム